Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul
2ª Vara Judicial da Comarca de Estância Velha

Av. Sete de Setembro, 70 - Bairro: União - CEP: 93610-660 - Fone: 51-3098-5396 - 51-9.9569-1273 (WhatsApp) - Email: frestvelha2vjud@tjrs.jus.br

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL Nº 5004258-75.2024.8.21.0095/RS

AUTOR: EGYDIO ALFREDO MULLER
RÉU: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
RÉU: MUNICÍPIO DE ESTÂNCIA VELHA / RS

SENTENÇA

I - RELATÓRIO

EGYDIO ALFREDO MULLER, devidamente qualificado nos autos, ajuizou a presente ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência em face do ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, do MUNICÍPIO DE ESTÂNCIA VELHA e da UNIÃO FEDERAL, igualmente qualificados, objetivando a condenação dos réus na obrigação de fazer consistente no fornecimento e/ou custeio do procedimento cirúrgico para retirada do tumor (Ressecção Retroperitoneal) e possível reconstrução vascular. Em sua petição inicial, o autor narrou ser portador de sarcoma retroperitoneal, necessitando com urgência de procedimento cirúrgico para retirada do tumor (Ressecção Retroperitoneal), com provável necessidade de reconstrução vascular. Relatou que realizou uma cirurgia em fevereiro de 2024 para retirada do tumor, contudo, quando abriram a região da barriga, devido ao tamanho que a doença se encontrava, não conseguiram realizar o procedimento, pois o Hospital de Taquara não tinha suporte adequado para cirurgia de alta complexidade. Informou que o laudo médico apontava a progressão da doença caso não realizada a cirurgia. Discorreu acerca do direito aplicável à espécie. Requereu, a concessão de tutela de urgência e, no mérito, a procedência dos pedidos, para que os demandados fossem compelidos a realizar a cirurgia para retirada do tumor (Ressecção Retroperitoneal), com provável reconstrução vascular, nos termos do laudo médico, sob pena de multa diária por descumprimento, ou alternativamente, o bloqueio nas contas judiciais dos demandados do valor de R$ 70.970,00 (orçamento de menor valor), mais honorários médicos no valor de R$ 80.000,00, totalizando R$ 150.970,00. Pediu, ainda, a concessão da gratuidade de justiça (**Evento 1, INIC1**).

A ação foi originalmente ajuizada perante a Justiça Federal, sob o nº 5006667-41.2024.4.04.7108, perante o juízo da 1ª Vara Federal de Novo Hamburgo, tendo sido declinada a competência para esta Comarca, conforme decisão proferida no **Agravo de Instrumento nº 50218001020244040000**, com a exclusão da União do polo passivo da demanda.

O pedido liminar foi inicialmente indeferido pelo Juízo Federal (**Evento 3, DESPADEC1**), tendo sido posteriormente deferido por este Juízo (**Evento 58, DESPADEC1**), determinando-se que o Estado do Rio Grande do Sul e o Município de Estância Velha, no prazo de 15 (quinze) dias, realizassem a cirurgia para retirada do tumor (Ressecção Retroperitoneal), com provável reconstrução vascular, nos termos do laudo médico, sob pena de bloqueio de valores.

O Estado do Rio Grande do Sul apresentou contestação (**Evento 35, CONT1**), arguindo, preliminarmente, a ilegitimidade passiva, sob o argumento de que, no que tange a tratamentos oncológicos, não compete ao gestor estadual o financiamento ou a definição dos medicamentos e procedimentos que serão ou não utilizados no tratamento da doença. No mérito, sustentou que a responsabilidade pelo fornecimento do tratamento vindicado deve recair exclusivamente sobre a União, repassando, previamente, ao Estado o valor necessário ao custeio do tratamento requerido. Requereu, ao final, a improcedência do pedido, ou, subsidiariamente, que em caso de procedência da ação, fosse expressamente reconhecido na decisão que o custeio do tratamento oncológico é responsabilidade da União, devendo ser financiado com recursos federais, ressarcindo-se o Estado de forma integral nos próprios autos caso haja sequestro de valores ou, subsidiariamente, facultando-se o ressarcimento na esfera administrativa. Pediu, ainda, que os honorários advocatícios, em atenção ao princípio da causalidade, fossem fixados exclusivamente em desfavor da União.

O Município de Estância Velha também apresentou contestação (**Evento 38, CONT1**), arguindo, preliminarmente, a ilegitimidade passiva, sob o argumento de que aderiu ao processo de habilitação na Gestão da Atenção Básica, em que o tratamento de alta complexidade, como é o caso do pretendido pela parte autora (Ressecção Retroperitoneal), cabe à União. No mérito, sustentou que o Tema 793 do STF estabeleceu que os entes são solidariamente competentes nas demandas prestacionais na área da saúde, todavia, deixou claro que diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências. Requereu, ao final, o acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva suscitada, com a consequente extinção do feito, sem resolução de mérito, nos moldes do art. 485, VI, do CPC; no mérito, requereu a improcedência dos pedidos, ou, subsidiariamente, requereu que, em caso de manutenção da obrigação solidária do Município, a mesma fosse limitada em no máximo 25% do custo total da internação.

No **Evento 48, DESPADEC1**, este Juízo recebeu o feito declinado da 1ª Vara Federal de Novo Hamburgo e determinou a intimação da parte autora para apresentar réplica às contestações.

Houve réplica, oportunidade em que o autor juntou novos documentos e reiterou o pedido de tutela de urgência formulado na inicial, para que os demandados fossem compelidos a realizar a cirurgia para retirada do tumor (Ressecção Retroperitoneal), com provável reconstrução vascular, nos termos do laudo médico (**Evento 53, RÉPLICA1**).

No **Evento 58, DESPADEC1**, este Juízo afastou a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelos réus, em razão da responsabilidade solidária estabelecida entre os Entes Federados para o atendimento integral à saúde, e deferiu a tutela provisória de urgência para determinar que o Estado do Rio Grande do Sul e o Município de Estância Velha, no prazo

de 15 (quinze) dias, realizassem a cirurgia para retirada do tumor (Ressecção Retroperitoneal), com provável reconstrução vascular, nos termos do laudo médico, sob pena de bloqueio de valores.

No **Evento 70, OUT1**, foi juntado aos autos o histórico da solicitação do paciente no sistema GERCON, demonstrando que o autor foi encaminhado para consulta com especialista em Oncologia Cirurgia Geral na Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre, tendo sido realizada a consulta em 27/11/2024.

No **Evento 70, PET1**, o Estado do Rio Grande do Sul informou que a parte autora estava sendo atendida pelo prestador de serviço referido, cumprindo-se a decisão antecipatória de tutela referente ao encaminhamento do paciente para a realização do procedimento necessário ao restabelecimento da saúde.

No **Evento 79, PET1**, a parte autora informou que o Estado e o Município não cumpriram a liminar deferida no **Evento 58, DESPADEC1**, requerendo o bloqueio de valores para a realização do procedimento cirúrgico.

No **Evento 81, DESPADEC1**, este Juízo determinou, a anteceder a efetivação do bloqueio online nas contas dos réus, a intimação da parte autora para que junte aos autos 3 (três) orçamentos atualizados, o que foi atendido pela parte requerente no **Evento 86**.

No **Evento 89, DESPADEC1**, este Juízo determinou o bloqueio de valores do Estado do Rio Grande do Sul e do Município de Estância Velha, na proporção de metade da quantia para cada um diante da solidariedade, no valor total de R$ 159.240,00.

No **Evento 102, OUT2**, o Ente Público Estadual requereu a reconsideração da decisão que determinou o bloqueio de valores para fornecimento da cirurgia na rede privada, determinando-se a suspensão da expedição dos alvarás, dado que houve a emissão de AIH para internação e atendimento do autor na Santa Casa. Juntou aos autos a evolução médica ambulatorial do paciente, datada de 29/01/2025, realizada na Santa Casa de Porto Alegre, na qual constava que o paciente estava aguardando procedimento.

No **Evento 107, DESPADEC1**, este Juízo intimou o Estado do Rio Grande do Sul para informar, no prazo derradeiro de 3 dias, em que data seria agendada a cirurgia do autor na Santa Casa.

No **Evento 117, PET1**, o Estado do Rio Grande do Sul informou que a parte autora realizou o procedimento cirúrgico pelo SUS, requerendo a extinção do feito, com fulcro no art. 485, inc. VI, do CPC, sem ônus para o ente público.

No **Evento 122, DESPADEC1**, este Juízo consignou que o autor realizou o procedimento cirúrgico no dia 12/02/2025, tendo alta no dia 12/03/2025, determinando a liberação dos valores bloqueados no **Evento 89** em favor dos réus, visto o cumprimento da liminar.

Vieram os autos conclusos para sentença.

Relatei. Decido.

II - FUNDAMENTAÇÃO

O feito transcorreu normalmente e não há nulidades a serem sanadas.

Analiso, de início, as questões processuais pendentes.

1. Da preliminar de ilegitimidade passiva

Alegaram os réus que a tese fixada no TEMA 793 do STF, que determina a observância da questão da repartição de competências no âmbito do SUS, deve ser aplicada ao presente caso concreto, requerendo a emenda da inicial para inclusão da União no polo passivo da demanda, com a remessa dos autos à Justiça Federal.

No entanto, **resta prejudicada a análise da referida preliminar**, em sentença, pois tal questão já foi analisada pelo juízo federal, por ocasião do julgamento do **Agravo de Instrumento nº 50218001020244040000/TRF4**, no qual foi reconhecida, de ofício, a ilegitimidade passiva da União e determinada a sua exclusão da lide, bem como determinada a remessa dos autos principais à Justiça Estadual.

Diante disso, reputo **prejudicada** a preliminar suscitada pelo ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL e pelo MUNICÍPIO DE ESTÂNCIA VELHA.

2. Da perda do objeto da demanda.

No **Evento 117, PET1**, o ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL requereu a extinção do feito, com fulcro no art. 485, inc. VI, do CPC, sem ônus para o ente público, tendo em vista que a parte autora recebeu o tratamento vindicado, configuramdo-se a perda de objeto na presente demanda.

Com efeito, não há que se falar em perda do objeto, tendo em vista que o deferimento da consulta e cirurgia postulada somente ocorreu após o ajuizamento desta demanda e deferimento liminar.

Nesse sentido:

> *APELAÇÃO CÍVEL. **DIREITO À SAÚDE**. **FORNECIMENTO DE CONSULTA E PROCEDIMENTO CIRÚRGICO**. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. DEVER CONSTITUCIONAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. **EXTINÇÃO PELA PERDA DO OBJETO. INOCORRÊNCIA**. PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. 1. **Não há que se falar em perda do objeto, tendo em vista que o deferimento da consulta e cirurgia postulada somente ocorreu após o ajuizamento desta demanda e deferimento liminar.** 2. O fornecimento gratuito de medicamentos e demais serviços de saúde constitui responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, derivada*

do artigo 196 da Constituição Federal c/c o art. 241 da Constituição Estadual. Precedentes do STF e STJ. 3. Caso concreto em que não houve o cumprimento espontâneo da obrigação, hipótese em que acarretaria a extinção do feito pela perda do objeto, com base no art. 485, inciso VI, do CPC. Ao contrário, foi necessário o deferimento da liminar para que a parte obtivesse acesso à consulta postulada sem, contudo, ter havido o agendamento da cirurgia de que necessita. APELO CONHECIDO E PROVIDO.(Apelação Cível, Nº 50200958120238210039, Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Diego Carvalho Locatelli, Julgado em: 05-02-2025) - grifei.

Portanto, **rejeito** a preliminar de perda superveniente do objeto do pedido arguida pelo corréu ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL.

Inexistentes demais questões processuais pendentes, **passo à análise do mérito**.

3. Do mérito

O direito à saúde, de natureza fundamental (art. 6º da CF/88), é garantido mediante (i.) a implementação de políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e (ii.) o acesso universal e igualitário às ações e serviços para promoção, proteção e recuperação (art. 196 da CF/88).

Para a realização deste direito, determinou o art. 198 da CF/88 a formação de uma rede regionalizada e hierarquizada em um sistema único e descentralizado – Sistema Único de Saúde (SUS) -, cujas diretrizes são as seguintes:

"I - descentralização, com direção única em cada esfera de governo;

II - atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais;

III - participação da comunidade."

A diretriz do atendimento integral para a saúde compreende, evidentemente, a assistência farmacêutica. Por se tratar de uma obrigação comum dos entes federados (art. 23, II, c/c art. 196 da CF/88), a realização do direito à saúde é disciplinada por leis e regulamentos administrativos, que discriminam a competência de cada um dos entes da Federação.

O Supremo Tribunal Federal decidiu a questão em dois Temas com repercussão geral, a saber, o de nº 500 e o de nº 793, que afirmaram as seguintes teses:

Tema 500: 1. O Estado não pode ser obrigado a fornecer medicamentos experimentais. 2. A ausência de registro na ANVISA impede, como regra geral, o fornecimento de medicamento por decisão judicial. 3. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento sem registro sanitário, em caso de mora irrazoável da ANVISA em apreciar o pedido (prazo superior ao previsto na Lei nº 13.411/2016), quando preenchidos três requisitos: (i) a existência de pedido de registro do medicamento no Brasil (salvo no caso de medicamentos órfãos para doenças raras e ultrarraras);(ii) a existência de registro do medicamento em renomadas agências de regulação no exterior; e (iii) a inexistência de substituto terapêutico com registro no Brasil. 4. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Tema 793: Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

Logo, tem-se que: a) persiste a solidariedade no atendimento do direito à saúde; b) em princípio, deve-se atentar para a ordenação administrativa do SUS; c) a falta de fármaco nas listas de dispensação pode ser suprida no caso de omissão injustificada da Administração Pública, vedando-se os fármacos sem registro e importados ou procedimentos clínicos e cirúrgicos de caráter experimental (art. 19-T da Lei nº 8.080/90).

Todavia, da leitura do acórdão dos EdCl no RE nº 855.178/SE, que gerou a edição da súmula do Tema nº 793 do Supremo Tribunal Federal, verifica-se que a tese realmente firmada por maioria foi a sustentada pelo Min. Edson Fachin, o qual, em seu voto, firmou as seguintes conclusões:

"i) A obrigação a que se relaciona a reconhecida responsabilidade solidária é a decorrente da competência material comum prevista no artigo 23, II, CF, de prestar saúde, em sentido lato, ou seja: de promover, em seu âmbito de atuação, as ações sanitárias que lhe forem destinadas, por meio de critérios de hierarquização e descentralização (arts. 196 e ss. CF); ii) Afirmar que "o polo passivo pode ser composto por qualquer um deles (entes), isoladamente ou conjuntamente" significa que o usuário, nos termos da Constituição (arts. 196 e ss.) e da legislação pertinente (sobretudo a lei orgânica do SUS n. 8.080/90) tem direito a uma prestação solidária, nada obstante cada ente tenha o dever de responder por prestações específicas ; iii) Ainda que as normas de regência (Lei 8.080/90 e alterações, Decreto 7.508/11, e as pactuações realizadas na Comissão Intergestores Tripartite) imputem expressamente a determinado ente a responsabilidade principal (de financiar a aquisição) pela prestação pleiteada, é lícito à parte incluir outro ente no polo passivo, como responsável pela obrigação, para ampliar sua garantia, como decorrência da adoção da tese da solidariedade pelo dever geral de prestar saúde; iv) Se o ente legalmente responsável pelo financiamento da obrigação principal não compuser o polo passivo da relação jurídico processual, compete a autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento ; v) Se a pretensão veicular pedido de tratamento, procedimento, material ou medicamento não incluído nas políticas públicas (em todas as suas hipóteses), a União necessariamente comporá o polo passivo, considerando que o Ministério da Saúde detém competência para a incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos, procedimentos, bem como constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica (art. 19- Q, Lei 8.080/90), de modo que recai sobre ela o dever de indicar o motivo da não padronização e eventualmente iniciar o procedimento de análise de inclusão, nos termos da fundamentação; vi) A dispensa judicial de medicamentos, materiais, procedimentos e tratamentos pressupõe ausência ou ineficácia da prestação administrativa e a comprovada necessidade, observando, para tanto, os parâmetros definidos no artigo 28 do Decreto federal n. 7.508/11."

De acordo com estas conclusões, pode-se afirmar, então, que o conceito de solidariedade, até então adotado, foi modificado pelo Supremo Tribunal Federal. Conforme esta decisão, em caso de pedido de fornecimento de tratamento ou medicamento não incluído nas políticas públicas, a ação deverá ser dirigida necessariamente contra a União. Já para os tratamentos e medicamentos incluídos nas políticas públicas, deve a autoridade judiciária imputar a responsabilidade ao ente competente, admitido, neste caso, o direcionamento da ação contra outro ente, que ficaria com a obrigação solidária perante o cidadão, mas, neste caso, cabe ao Poder Judiciário atribuir a obrigação de ressarcimento àquele que tem a obrigação material de fornecer a prestação de saúde postulada.

O acórdão foi publicado no dia 16.04.2020, transitou em julgado em 08.09.2020 e vinha sendo aplicado pelo Supremo Tribunal Federal em decisões recentes, como se colhe da leitura dos seguintes precedentes:

> *"AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PREVISTO NO REGULAMENTO DO SUS. INCLUSÃO DA UNIÃO DO POLO PASSIVO. TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. DECISÃO RECORRIDA EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. 1. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 855.178 (Rel. Min. LUIZ FUX, Tema 793), examinou a repercussão geral da questão constitucional debatida nestes autos e reafirmou a jurisprudência desta CORTE no sentido da responsabilidade solidária dos entes federados do dever de prestar assistência à saúde. 2. Posteriormente, ao rejeitar os embargos de declaração opostos em face deste acórdão, o SUPREMO fixou a seguinte tese: "Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro". 3. No caso concreto, ao determinar a inclusão da União no polo passivo da demanda, com a consequente remessa dos autos à Justiça Federal, o Tribunal de origem seguiu a tese de repercussão geral. 4. Agravo Interno a que se nega provimento." (ARE 1301670 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 13/04/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-073 DIVULG 16-04-2021 PUBLIC 19-04-2021)*
>
> *"AGRAVO INTERNO NA SUSPENSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DA UNIÃO, ESTADO E MUNICÍPIO. INOBSERVÂNCIA DO QUE DECIDIDO NO RE 855.178 – TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE RISCO À ORDEM PÚBLICA E ECONÔMICA. OCORRÊNCIA. ELEVADO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SAÚDE EM COMPARAÇÃO AO ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO AUTOR. MEDIDA LIMINAR CONFIRMADA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE SUSPENSÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A natureza excepcional da contracautela permite tão somente juízo mínimo de delibação sobre a matéria de fundo e análise do risco de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas (SS 5.049-AgR-ED, rel. Min. Presidente Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe de 16/5/2016). 2. No julgamento do RE 855.178 - Tema 793 da repercussão geral, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, além de reafirmar a existência de responsabilidade solidária entre os entes federativos, assentou o dever de as autoridades judiciais direcionarem o cumprimento das decisões para fornecimento de prestações de saúde aos entes competentes, de acordo com as regras de organização do Sistema Único de Saúde. 3. A necessidade de direcionamento da execução da prestação de saúde à luz da repartição de competência advém da imperativa necessidade de racionalização administrativa e financeira do sistema, com vistas ao atingimento da máxima eficiência na aplicação dos recursos. 4. In casu, o valor da prestação de saúde imposta ao Município autor revela-se sobremaneira elevado proporcionalmente a sua capacidade econômica, de modo a gerar potencial lesão de natureza grave à economia pública e aos serviços municipais de saúde, ensejando, destarte, o deferimento do pedido de contracautela. 5. Inexiste na hipótese periculum in mora inverso para o particular autor, uma vez que a obrigação de fornecimento do medicamento resta mantida em face da União e do Estado de Santa Catarina, condenados solidariamente à prestação de saúde na origem. 6. Agravo interno a que se nega provimento." (STP 384 AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 13/04/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-085 DIVULG 04-05-2021 PUBLIC 05-05-2021)*

Por isso, salvo no caso de o tratamento postulado não estar incluído nas políticas públicas do Sistema Único de Saúde - hipótese que recomenda a inclusão da UNIÃO no polo passivo, com consequente deslocamento da competência para a Justiça Federal -, nos demais casos é lícito ao paciente demandar, solidariamente, os demais entes responsáveis pelo serviço de saúde (ESTADO e MUNICÍPIOS), cabendo, porém, ao Julgador direcionar o cumprimento conforme a repartição de competência no âmbito administrativo.

Mais recentemente, contudo, o Superior Tribunal de Justiça proferiu a seguinte decisão no CC nº 187.276/RS:

> *"PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. DIREITO À SAÚDE. MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS E REGISTRADO NA ANVISA. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZOS FEDERAL E ESTADUAL. PROPOSTA. ACOLHIMENTO. 1. Trata-se de proposta de incidente de assunção de competência, nos termos do art. 947 do Código de Processo Civil/2015, em conflito negativo de competência instaurado nos autos de ação ordinária que versa sobre o fornecimento de medicação não padronizada pelo Sistema Único de Saúde - SUS. 2. A instauração do presente incidente visa unicamente decidir o juízo competente para o julgamento de demanda relativa à dispensação de tratamento médico não incluído nas políticas públicas, sendo o conflito de competência o processo adequado para dirimir a questão de direito processual controvertida, sem que haja necessidade de adentrar no mérito da causa (onde suscitado o conflito) – ainda que a discussão se refira a preliminar, como, no caso, a legitimidade ad causam – nem em eventual nulidade da decisão do Juízo Federal, matérias que devem ser analisadas no bojo da ação ordinária. 3. Delimitação da tese controvertida: Tratando-se de medicamento não incluído nas políticas públicas, mas devidamente registrado na ANVISA, analisar se compete ao autor a faculdade de eleger contra quem pretende demandar, em face da responsabilidade solidária dos entes federados na prestação de saúde, e, em consequência, examinar se é indevida a inclusão da União no polo passivo da demanda, seja por ato de ofício, seja por intimação da parte para emendar a inicial, sem prévia consulta à Justiça Federal. 4. Proposta de julgamento do tema mediante a sistemática do incidente de assunção de competência acolhida."*

Ao final desta decisão - que busca definir qual deve ser o procedimento adotado quanto à competência, fixou o Superior Tribunal de Justiça os seguintes comandos:

> *"c) manutenção do curso das ações que versam sobre a dispensação de tratamento/medicamento não incluído nas políticas públicas, visto que a suspensão dos feitos poderia causar dano de difícil reparação àqueles que necessitam da tutela do direito à saúde;*
>
> *d) havendo conflito de competência, fica, nos termos do art. 955 do CPC/2015, designado o Juízo estadual para decidir, em caráter provisório, as medidas urgentes referentes aos processos em comento;*
>
> *e) cumpridas as diligências, sejam os autos encaminhados ao Ministério Público Federal para manifestação e, após, seja a questão que foi delimitada nos conflitos de competência submetida à apreciação da Primeira Seção desta Corte de Justiça."*

Ainda, não se pode olvidar a decisão que deferiu parcialmente a tutela provisória nos autos do RE 1366243 (**Tema n° 1.234 do STF**), determinou que as ações referentes ao medicamentos/procedimentos não incorporados a lista do SUS permaneçam no Juízo de origem até julgamento definitivo do tema. Nesse sentido, de resto, a jurisprudência do TJRS:

> *AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE (ECA E IDOSO). CANABIDIOL. MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. RE 1366243 (TEMA 1234). MANUTENÇÃO DOS AUTOS NESTA JUSTIÇA ESTADUAL. TEMA 500/STF. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. O Ministro Gilmar Mendes, ao deferir parcialmente tutela provisória nos autos do RE 1366243 (Tema 1234), determinou que as demandas relativas a medicamentos e procedimentos não incorporados ao SUS permaneçam no Juízo para o qual foram direcionadas até o julgamento definitivo do tema por aquela Corte Superior, in verbis:" (ii) devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de*

inclusão da União no polo passivo". Por isso, conquanto postulado o fornecimento de terapias não incorporada ao SUS, descabe determinar a inclusão da União no polo passivo, bem como a remessa dos autos à Justiça Federal. 2. Inaplicabilidade do Tema 500/STF, uma vez que o medicamento em questão (Canabidiol Prati-Donaduzzi 200mg/mL) já obteve autorização sanitária junto à ANVISA, com base na nº RDC 327/2019 e possui número de registro cadastrado. 3. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. (Agravo de Instrumento, Nº 51748962420238217000, Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Denise Oliveira Cezar, Julgado em: 09-10-2023)

Importa salientar que, nos termos do Tema n° 1.234 do STF supramencionado, quando a prestação de saúde pleiteada pela parte não estiver enquadrada na política estatal, como no caso de utilização *off label*, deve ser entendida como não padronizada pelo SUS, haja vista não se tratar de mero cumprimento de política pública.

Feitas tais considerações, passo ao exame do caso concreto.

No caso dos autos, trata-se de ação que visa ao fornecimento de procedimento cirúrgico para Ressecção Retroperitoneal, com provável necessidade de reconstrução vascular, necessário ao tratamento de saúde do autor EGYDIO ALFREDO MULLER, que foi diagnosticado com a patologia Sarcoma Retroperitoneal, que refere-se à Neoplasia Maligna do Tecido Conjuntivo e de Outros Tecidos Moles (CID-10 C49).

Pois bem.

Ressalvado o fornecimento de medicamentos, em matéria de prestações específicas para a realização do direito à saúde (como ocorre com exames médicos, internações ou realização de cirurgias), em princípio, deve-se respeitar ordenação administrativa realizada por profissionais médicos habilitados, não podendo haver interferência do Poder Judiciário.

De outra parte, apenas no caso de **omissão injustificada** do Poder Público à prestação de saúde, é cabível determinar, judicialmente, o custeio da prestação de saúde pleiteada.

Quer dizer, conquanto tenha direito ao tratamento médico, apenas no caso de evidenciada a impossibilidade da prestação do serviço médico postulado na rede pública de saúde ou de **demora incompatível com a urgência do caso concreto**, é que se poderá determinar o custeio do tratamento médico em hospital privado.

Do contrário, acabaria por se onerar excessivamente os gestores públicos de saúde. Além disso, adotar medida tão gravosa ao erário sem ao menos submeter o paciente aos protocolos do SUS feriria a isonomia e o acesso igualitário às ações e serviços de saúde.

No caso dos autos, restou comprovado que o autor é portador de Sarcoma Retroperitoneal, necessitando com urgência de procedimento cirúrgico para retirada do tumor (Ressecção Retroperitoneal), com provável necessidade de reconstrução vascular, conforme laudos médicos (**Evento 1, LAUDO6** e **Evento 1, LAUDO7**) juntados aos autos.

Assim, **resultou configurada a situação de demora incompatível com a urgência do caso concreto**, pois o laudo médico juntado aos autos demonstra a necessidade do procedimento cirúrgico para retirada do tumor, bem como o risco de progressão da doença caso não realizada a cirurgia.

Ademais, restou comprovado que o autor realizou uma cirurgia em fevereiro de 2024 para retirada do tumor, contudo, quando abriram a região da barriga, devido ao tamanho que a doença se encontrava, não conseguiram realizar o procedimento, pois o Hospital de Taquara não tinha suporte adequado para cirurgia de alta complexidade, conforme se verifica pela DECLARAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE TÉCNICA DE ATENDIMENTO NA REFERÊNCIA REGIONAL juntada no **Evento 53, OUT2** dos autos.

Diante da gravidade do quadro clínico do autor e da necessidade do procedimento cirúrgico para retirada do tumor, **este Juízo deferiu a tutela provisória de urgência** para determinar que os réus realizassem a cirurgia para retirada do tumor (Ressecção Retroperitoneal), com provável reconstrução vascular, nos termos do laudo médico, sob pena de bloqueio de valores.

Além disso, conforme informado pelo Estado do Rio Grande do Sul no **Evento 117, PET1**, a parte autora realizou o procedimento cirúrgico pelo SUS, tendo sido realizada a cirurgia no dia **12/02/2025**, com alta no dia **12/03/2025**, conforme consignado no **Evento 122, DESPADEC1**.

Assim, verifica-se que o pedido formulado na inicial foi atendido, tendo sido realizado o procedimento cirúrgico para retirada do tumor (Ressecção Retroperitoneal) e possível reconstrução vascular.

Além disso, a parte autora comprovou a sua incapacidade financeira de custear o tratamento, conforme declaração de hipossuficiência (Evento 1, PROC2) e comprovante de rendimentos (**Evento 1, COMP5**) juntados aos autos, ao passo que o procedimento cirúrgico foi orçado em R$ 150.970,00.

Nesse quadro, **a procedência do pedido é medida que se impõe**, porquanto comprovada a necessidade da realização de cirurgia, a ausência de recursos da parte e a impossibilidade de substituição por outros tratamentos disponibilizados pelo SUS. Por tais fundamentos, tenho que os entes públicos requeridos são responsáveis pelo fornecimento do tratamento cirúrgico indicado à parte autora, merecendo procedência o pleito da inicial, confirmando-se a liminar anteriormente concedida.

III - DISPOSITIVO

Diante do exposto, com base no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, **JULGO PROCEDENTE** o pedido formulado por EGYDIO ALFREDO MULLER em face do ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL e do MUNICÍPIO DE ESTÂNCIA VELHA, para, **confirmando a tutela de urgência anteriormente concedida**, condenar os réus na

obrigação de fazer consistente no fornecimento e/ou custeio do procedimento cirúrgico para retirada do tumor (Ressecção Retroperitoneal) e possível reconstrução vascular.

Consigno, por fim, que a obrigação de fazer imposta nesta sentença já foi integralmente cumprida pelos entes públicos demandados.

Sucumbente, condeno a parte ré, na proporção de 50% para cada requerido, ao pagamento de honorários advocatícios em favor do(a) procurador da parte autora, que fixo em 10% sobre o valor da causa, quantia que deverá ser atualizada monetariamente pelo índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), a contar da data do arbitramento (data da publicação da sentença), até o efetivo pagamento, acumulada mensalmente, de acordo com os parâmetros da Emenda Constitucional nº 113/21, considerado o trabalho desempenhado, a natureza repetitiva da demanda e a extensão da controvérsia, com base art. 85, § 3º, I, do CPC.

Sem custas (art. 5º, inciso I, e parágrafo único, da Lei nº 14.634/2014).

Publicada e registrada a sentença, bem como intimadas as partes da presente decisão, automaticamente, via sistema Eproc.

Diante do que disciplina o parágrafo 3º do artigo 1.010 da Lei 13.105/2015, acaso seja interposto recurso de apelação, intime-se a parte contrária, independentemente de conclusão (ato ordinatório – arts. 152, VI, CPC, e 567, XX, da Consolidação Normativa Judicial), para contrarrazões, no prazo de 15 dias (art. 1.010, §2º, CPC), remetendo-se em seguida os autos ao Tribunal de Justiça.

A presente sentença **não está sujeita** ao duplo grau de jurisdição, pois o proveito econômico obtido na causa é inferior a 100 (cem) salários-mínimos. Logo, decorrido o prazo recursal sem a interposição de recurso voluntário, **atribua-se baixa**.

Documento assinado eletronicamente por **MAURICIO DA ROSA AVILA, Juiz de Direito**, em 03/10/2025, às 15:39:24, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://eproc1g.tjrs.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, informando o código verificador **10091974133v2** e o código CRC **2152fc5a**.